

Kiểm Soát Dịch Qua Ăn Uống Ở Người Bệnh Chạy Thận Nhân Tạo

Hướng dẫn toàn diện giúp người bệnh chạy thận nhân tạo kiểm soát lượng dịch, bảo vệ sức khỏe tim mạch và nâng cao chất lượng cuộc sống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

01

Tài liệu "Hãy gìn giữ thận của bạn" — bản tiếng Việt, Kidney Education Foundation

<https://kidneyeducation.com/vietnamese>

02

National Kidney Foundation — Fluid Overload in a Dialysis Patient, What Is Dry Weight?

<https://www.kidney.org/kidney-topics/fluid-overload-dialysis-patient>

03

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases — Eating & Nutrition for Hemodialysis

<https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidney-failure/hemodialysis/eating-nutrition>

04

KDOQI Clinical Practice Guideline for Hemodialysis Adequacy: 2015 Update

[https://www.ajkd.org/article/S0272-6386\(15\)01019-7/fulltext](https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(15)01019-7/fulltext)

05

Agency for Healthcare Research and Quality — Patient Education Materials Assessment Tool (PEMAT)

<https://www.ahrq.gov/health-literacy/patient-education/pemat.html>

1. Vì Sao Người Chạy Thận Dễ Bị Quá Tải Dịch?

Thận là cơ quan có vai trò quan trọng trong việc lọc máu, thải chất độc, điều hòa nước – muối – điện giải và tạo nước tiểu.

Khi thận suy giai đoạn cuối, chức năng lọc máu và tạo nước tiểu giảm nặng. Nước, muối và các chất thải không còn được thải ra ngoài đầy đủ như trước. Do đó, nước từ đồ uống và thức ăn có thể tích lại trong cơ thể, đặc biệt ở người bệnh đi tiểu ít hoặc không còn nước tiểu.

Chạy thận nhân tạo giúp lấy bớt chất thải, muối và nước dư ra khỏi máu. Tuy nhiên, giữa hai lần lọc máu, dịch vẫn tiếp tục tích lại nếu người bệnh uống nhiều, ăn nhiều món lỏng hoặc ăn mặn.

2. Quá Tải Dịch Là Gì và Nguy Hiểm Như Thế Nào?

Quá tải dịch là tình trạng cơ thể tích tụ quá nhiều nước. Ở người bệnh chạy thận nhân tạo, tình trạng này thường được nhận biết qua tăng cân nhanh giữa hai lần lọc máu, phù, khó thở hoặc huyết áp tăng.

Quá tải dịch nếu kéo dài có thể làm tăng gánh nặng cho tim và phổi. Người bệnh có thể cảm thấy khó thở, nặng ngực, ho nhiều về đêm hoặc phải nhập viện cấp cứu.

Dấu hiệu cần chú ý

- **Phù:** Mặt, bàn chân, cổ chân, bàn tay hoặc bụng sưng hơn bình thường. Giày dép, nấn hoặc quần áo có thể chật hơn.
- **Tăng cân nhanh:** Cân nặng tăng nhanh sau buổi lọc trước, thường do cơ thể giữ dịch.
- **Khó thở:** Khó thở khi nằm, khi gắng sức hoặc ho nhiều về đêm.
- **Huyết áp bất thường:** Huyết áp cao trước lọc hoặc thay đổi bất thường so với mức được dặn.
- **Trong lọc máu:** Có thể mệt, chuột rút, chóng mặt hoặc tụt huyết áp khi phải rút nhiều dịch.

Thông điệp chính

- ⚠ Tăng cân nhanh, phù, khó thở hoặc huyết áp bất thường là các dấu hiệu quan trọng, cần được theo dõi và báo cho nhân viên y tế.

3. Cân Nặng Khô và Tăng Cân Giữa Hai Lần Lọc

Cân nặng khô là gì?

Cân nặng khô là cân nặng gần đúng sau buổi lọc máu khi cơ thể không còn dư nước rõ rệt. Đây là **mốc quan trọng** để đánh giá tình trạng dịch trong cơ thể.

Cân nặng khô **không phải là một con số cố định mãi mãi**. Con số này có thể thay đổi theo tình trạng dinh dưỡng, phù, huyết áp, triệu chứng khi lọc máu và đánh giá của bác sĩ.

Cần theo dõi và báo ngay khi có:

- Phù tăng
- Khó thở
- Tăng huyết áp
- Chuột rút nhiều
- Chóng mặt hoặc tụt huyết áp trong buổi lọc

Khi cân nặng tăng vượt mức được dặn, kèm phù, khó thở hoặc huyết áp bất thường.

📌 Thông điệp chính: Cân nặng khô là mốc theo dõi dịch. Tăng cân nhanh giữa hai lần lọc thường là dấu hiệu cơ thể đang giữ nước.

4. Lượng Dịch Được Dùng Mỗi Ngày Là Bao Nhiêu?

Lượng dịch được dùng mỗi ngày không giống nhau ở mọi người bệnh. Con số này cần được **cá thể hóa** dựa trên lượng nước tiểu còn lại, cân nặng khô, mức tăng cân giữa hai lần lọc, tình trạng phù, huyết áp, lịch lọc máu và đánh giá của nhân viên y tế.

Công thức tham khảo

Ở người bệnh còn nước tiểu, lượng dịch mỗi ngày có thể được tính dựa trên lượng nước tiểu 24 giờ cộng thêm một phần bù:

$$\text{Lượng dịch/ngày} = \text{Lượng nước tiểu 24 giờ} + 500 \text{ ml}$$

Phần 500 ml là lượng dịch ước tính mất qua mồ hôi và hơi thở. Tuy nhiên, đây chỉ là công thức tham khảo.

Lưu ý quan trọng

Lượng dịch thực tế cần theo hướng dẫn của bác sĩ, điều dưỡng hoặc chuyên gia dinh dưỡng.



Không tự uống nhiều nước để "bảo vệ thận".
Lượng dịch mỗi ngày cần được cá thể hóa và phải theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

5. Những Món Nào Được Tính Là Dịch?

Khi kiểm soát dịch, không chỉ nước lọc mới được tính. **Tất cả đồ uống và món ăn dạng lỏng**, hoặc có thể tan thành lỏng, đều cần được tính vào tổng lượng dịch trong ngày. Nếu chỉ đếm nước lọc mà quên canh, súp, cháo loãng, sữa, đá viên hoặc thạch, người bệnh có thể vượt lượng dịch được phép mà không biết.

Nước uống

Nước lọc, trà, cà phê, nước đá viên

Nước dùng với thuốc

Nước uống thuốc sáng/tối

Món ăn nước

Canh, súp, nước phở, nước bún

Món dạng lỏng

Cháo loãng, sữa, sữa chua, sinh tố

Món đông/lạnh

Đá viên, kem, thạch, rau câu

Trái cây nhiều nước

Dưa hấu, cam, bưởi, nho... (có thể chứa thêm Kali)

Thông điệp chính: Dịch không chỉ là nước lọc. Canh, súp, cháo loãng, sữa, đá viên, thạch và trái cây nhiều nước đều có thể góp phần làm dư nước trong cơ thể.

6. Cách Đong, Chia và Ghi Lượng Dịch Trong Ngày

Kiểm soát dịch hiệu quả cần có dụng cụ đo cụ thể. Người bệnh nên sử dụng ly cố định, bình chia vạch, chai có dung tích rõ hoặc nhật ký ghi lượng dịch. Cách này giúp biết đã dùng bao nhiêu dịch, còn lại bao nhiêu và khi nào cần dừng lại.

Một phương pháp dễ thực hiện là dùng một bình chứa lượng dịch được phép trong ngày. Mỗi buổi sáng, cho vào bình đúng lượng dịch theo hướng dẫn. Mỗi lần uống nước hoặc dùng món lỏng, trừ lượng tương ứng khỏi bình. Khi bình hết nước, nghĩa là lượng dịch trong ngày đã dùng hết.

1 Chuẩn bị bình đo

Chuẩn bị một bình sạch có chia vạch hoặc biết rõ dung tích.

2 Đổ đúng lượng dịch mỗi sáng

Mỗi buổi sáng, đổ vào bình đúng lượng dịch được phép dùng trong ngày, ví dụ 1.000 ml hoặc 1.500 ml theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

3 Trừ lượng tương ứng mỗi lần dùng

Mỗi lần uống nước hoặc dùng món lỏng như sữa, canh, súp, cháo loãng, đá viên, thạch, nước ép, cần trừ lượng tương ứng ra khỏi bình.

Ví dụ: Ăn 100ml canh thì phải ghi nhận và loại bỏ 100ml nước lọc ra khỏi bình chứa. Uống 150ml sữa thì phải ghi nhận và loại bỏ 150ml nước lọc ra khỏi bình chứa.

4 Khi bình hết nước

Khi bình hết nước, nghĩa là lượng dịch được phép trong ngày đã dùng hết. Không dùng thêm dịch nếu chưa được nhân viên y tế hướng dẫn.

5 Thực hiện hằng ngày

Thực hiện hằng ngày để tạo thói quen kiểm soát dịch và phòng quá tải dịch. Ngoài ra, lượng dịch nên được chia đều trong ngày. Không nên dùng quá nhiều dịch vào một thời điểm vì có thể làm hết lượng dịch được phép quá sớm và gây khát nhiều vào cuối ngày.

✔ **Thông điệp chính:** Đong đúng, ghi đủ và chia đều lượng dịch giúp kiểm soát dịch chủ động hơn và giảm nguy cơ quá tải dịch.

7. Kiểm Soát Natri/Muối Để Giảm Khát và Giảm Giữ Nước

Muối ăn chứa natri. Natri giúp duy trì lượng dịch và huyết áp, nhưng khi thận suy, cơ thể khó thải bớt natri và nước dư. Ăn nhiều natri làm cơ thể giữ nước, tăng cảm giác khát và có thể làm huyết áp khó kiểm soát. Khi khát nhiều, người bệnh dễ uống vượt mức dịch được hướng dẫn.

Natri ẩn trong nhiều thực phẩm

Natri không chỉ có trong muối ăn. Natri còn có trong nước mắm, nước tương, bột nêm, hạt nêm, nước sốt, mì gói, đồ hộp, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh và một số thuốc hoặc sản phẩm bổ sung. Một số thực phẩm có nhiều natri dù không có vị quá mặn, còn gọi là **natri ẩn**.

Giảm natri không có nghĩa là ăn không ngon. Có thể giảm dần lượng nước mắm, nước tương, bột nêm và các gia vị mặn. Có thể dùng hành, tỏi, tiêu, chanh, giấm, rau thơm hoặc gia vị phù hợp để tăng mùi vị thay cho việc nêm mặn.

Nhóm sản phẩm chứa natri cần lưu ý	
Natri clorua	Muối, nước mắm, nước tương, bột canh, bột nêm, hạt nêm
Thực phẩm muối chua	Dưa muối, cà muối, mắm, cá khô
Nước sốt	Tương ớt, sốt cà, sốt đóng chai, sốt trộn sẵn
Natri alginate	Trong kem và sữa sô cô la
Natri bicarbonat	Trong bột nở và soda
Natri nitrate	Xúc xích, thịt nguội, chả lụa, đồ hộp
Natri citrate	Thạch, đồ tráng miệng, đồ uống giải khát
Thức ăn nhanh	Thức ăn nhanh
Natri saccharide	Chất tạo ngọt nhân tạo
Natri sulfite	Trái cây sấy khô
Thuốc/bổ sung	Thuốc sùi, kháng acid, bicarbonate natri

⚠ Khi dùng thực phẩm đóng gói, cần đọc nhãn để nhận biết natri. Một số nhãn có thể ghi "natri", "sodium", "muối" hoặc "salt". Một số sản phẩm ghi "ít natri" nhưng có thể thay natri bằng kali, không phù hợp với người chạy thận nếu chưa được hướng dẫn.

⊗ **Lưu ý an toàn:** Không tự dùng muối thay thế, muối kali, gia vị "ít natri", thuốc sùi hoặc thực phẩm bổ sung không rõ thành phần khi chưa hỏi nhân viên y tế. Một số sản phẩm có thể chứa kali hoặc natri ẩn, gây nguy cơ không an toàn cho người chạy thận.

ⓘ **Thông điệp chính:** Kiểm soát natri giúp giảm khát, giảm giữ nước, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và phòng quá tải dịch.

8. Khi Khát Nhiều, Nên Làm Gì?

Khát là cảm giác thường gặp ở người bệnh cần hạn chế dịch. Tuy nhiên, không phải lúc nào khát hoặc khô miệng cũng cần uống thêm nước. Có thể áp dụng nhiều cách để giảm khát mà không làm tăng nhanh lượng dịch đưa vào.

Khi khát, nên dùng ly nhỏ và nhấp từng ngụm nhỏ thay vì uống nhanh một lượng lớn. Nếu dùng đá viên nhỏ để giảm khát, cần tính đá viên vào tổng lượng dịch trong ngày. Khi khô miệng, có thể súc miệng rồi nhổ ra, đánh răng, làm ẩm môi hoặc dùng kẹo không đường nếu phù hợp.



Trời nóng

Giữ mát cơ thể, tránh nắng nóng kéo dài.



Hoạt động quá sức

Tránh gắng sức gây đổ mồ hôi nhiều nếu không cần thiết.



Hay uống khi nhàn rỗi

Chọn hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách, nghe nhạc, trò chuyện, làm việc phù hợp.



Có đái tháo đường

Kiểm soát đường máu theo hướng dẫn vì đường máu cao có thể làm khát nhiều hơn.



Cần uống thuốc

Có thể dùng một phần nước trong bữa ăn để uống thuốc nếu thuốc được phép uống cùng thức ăn. Không tự thay đổi cách dùng thuốc khi chưa hỏi nhân viên y tế.

✔ **Thông điệp chính:** Giảm khát không chỉ bằng cách uống nước. Chăm sóc miệng, dùng ly nhỏ, chia dịch trong ngày, ăn nhạt hơn và giữ cơ thể mát có thể giúp kiểm soát cơn khát tốt hơn.

10. Khi Nào Cần Báo Ngay Cho Nhân Viên Y Tế?

Người bệnh cần báo nhân viên y tế hoặc liên hệ đơn vị lọc máu khi có dấu hiệu gợi ý quá tải dịch hoặc bất thường trong quá trình điều trị. **Không nên chờ đến khi khó thở nhiều, phù nhiều hoặc mệt là mới đi khám.**

Dấu hiệu cần báo ngay

- Khó thở, nhất là khi nằm
- Phù tăng nhanh ở chân, mặt, tay, bụng
- Tăng cân nhanh hoặc vượt mức được dặn
- Huyết áp cao hoặc thấp bất thường
- Đau tức ngực, hồi hộp, mệt mỏi
- Chuột rút, chóng mặt, tụt huyết áp nhiều trong buổi lọc

Thông điệp chính

 Báo sớm giúp xử trí sớm. Khó thở, phù tăng, đau ngực, tăng cân nhanh hoặc huyết áp bất thường là các dấu hiệu không nên xem nhẹ.

Hãy luôn theo dõi cân nặng, tình trạng phù, huyết áp và các triệu chứng hằng ngày. Trao đổi thường xuyên với bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia dinh dưỡng để được hướng dẫn phù hợp với tình trạng cá nhân.

Tổng Kết

Kiểm soát dịch là một phần quan trọng trong điều trị chạy thận nhân tạo. Hiểu rõ về quá tải dịch, cân nặng khô, lượng dịch được phép, các nguồn dịch trong thực phẩm, cách đong dịch, kiểm soát natri, cách giảm khát và các dấu hiệu cần báo nhân viên y tế sẽ giúp người bệnh chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.



Theo dõi cân nặng

Ghi nhận cân nặng hằng ngày và báo nhân viên y tế khi tăng cân nhanh.



Đong đúng lượng dịch

Dùng bình chia vạch và ghi nhật ký dịch mỗi ngày.



Ăn nhạt hơn

Giảm natri để giảm khát và giảm giữ nước.



Báo sớm khi có dấu hiệu bất thường

Khó thở, phù tăng, đau ngực — không nên chờ đợi.